

Микронизированная флавоноидная терапия при геморрое беременных

Авторы:

Buckshee K, Takkar D, Aggarwal N.

Оригинальное название:

Micronized flavonoid therapy in internal hemorrhoids of pregnancy.

Журнал:

International Journal of Gynecology & Obstetrics. 1997 May; 57(2): 145-151.

PMID: 9184951 | DOI: 10.1016/s0020-7292(97)02889-0

PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9184951/>

Дизайн исследования

Открытое проспективное исследование.

Популяция: 50 беременных женщин с острым внутренним геморроем.

Препарат

Микронизированный диосмин 90% + гесперидин 10% (МОФФ (диосмин + гесперидин)).

Длительность: медиана 8 недель до родов + 4 недели после родов.

Ключевые результаты

- 66% (95% ДИ: 52.9–79.1) пациенток получили облегчение острых симптомов к 4-му дню лечения
- 53.6% (95% ДИ: 37.1–70.0, $P < 0.001$) — уменьшение числа рецидивов в антенатальном периоде
- Лечение хорошо переносилось
- Не повлияло на:
 - течение беременности
 - развитие плода
 - массу тела при рождении
 - рост и вскармливание ребёнка

Вывод авторов: «В краткосрочной перспективе микронизированный диосмин 90% + гесперидин 10% безопасен, приемлем и эффективен при лечении геморроя беременных.»

Значимость для клинической практики

Это ключевое исследование, непосредственно демонстрирующее эффективность и безопасность МОФФ (диосмин + гесперидин) у беременных женщин с геморроем. Подтверждает отсутствие негативного влияния на исход беременности и состояние новорождённого.